内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺炎

（性感认识：分类对比）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺炎概论

（一）患病环境

1.**社区**获得性肺炎 **CAP**

①在医院外发生的肺炎、或在医院外感染了有明确潜伏期的病原体而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎 无淋巴感染途径(肺的淋巴往外流,不会从外面流进肺内) VS 原发复合征的淋巴管炎属于肺结核播散方式,

②感染途径：空气吸入、误吸上呼吸道定植菌、邻近感染灶蔓延、血行播散等 不是感染途径

③常见病原体：**肺炎链球菌（最常见）、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌、呼吸道病毒**（病毒是成人 CAP 除细菌外的第二大常见病原体）练支一流兵

2.**医院**获得性肺炎 **HAP**

①在入院时不存在、也不处于潜伏期，在入院≥48 小时后在医院内新发生的肺炎

②感染途径：误吸**胃肠道**定植菌（胃食管反流病、脑卒中、醉酒等）、通过人工气道吸入环境中的致病菌 含G-杆菌和厌氧菌

③常见病原体：**G-杆菌（大肠杆菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌）和金葡菌** 绿脓杆菌

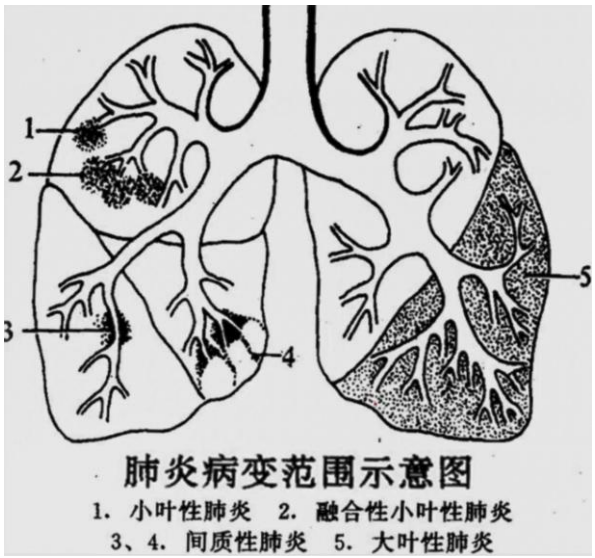
（打哱啵滤镜）

（二）检查

1.确定有无肺炎：X 线→CT

金黄色 砖红色胶冻样痰

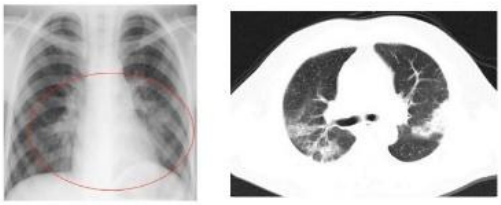
容易形成空洞（肺部感染治愈后常**遗留肺部瘢痕**）：**金葡菌（最易）、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧菌**（红绿黄臭） 肺组织坏死→引流支气管排走,重新充入空气→空洞→肉芽组织修复→纤维瘢痕



大叶性肺炎病变在肺泡,顺肺泡间孔蔓延,支气管未受累,从而被衬托出来-支气管充气征



本例 X 线片：右肺上叶大叶性肺炎.右上叶大片状密度增高影，密度均匀，以水平叶间裂为界，跨肺段但不跨肺叶 若跨过,则通过叶支气管播散
本例 CT 片：可见支气管充气征



小叶性肺炎：两肺中下野内中带肺纹理增多、模糊，多发斑片状阴影，肺小叶实变

小叶性肺炎:胸片-沿肺纹理分布的斑片影
CT-沿支气管血管束分布的斑片影

间质性肺炎:网格影、蜂窝影